הקבלה במרפאת טרום ניתוח

מה כותבים, איפה ואיך · תדרוך לסטאז׳רים ולמתמחים

על קוד של מתמחה
מציינים שהקבלה נכתבה על ידכם, כולל שם הסטאז׳ר/ית.

כל נושא ברובריקה שלו
בקמיליון: תרופות תחת תרופות, ניתוחים תחת ניתוחים.

לא משאירים לאשפוז
התורן בלילה עמוס. סוגרים הכול בטרום, כולל אק״ג.

בדיקה חסרה?
פקס למזכירת המחלקה: **08-9441790**

בסוף
מדפיסים וחותמים.

1 תלונה עיקרית

הופנה לניתוח _____ בשל _____ (האינדיקציה).

דוגמה: כריתת כיס מרה בגישה לפרוסקופית בשל אירועים חוזרים של דלקת.

2 מחלה נוכחית

- פותחים ב: **בן/בת XX, סובל/ת מ...** ומחלות הרקע בכותרות. הפירוט בהמשך.
- הדמיה (CT, MRI): עיקרי הפענוח עם תאריך. רק מה שרלוונטי, בלי העתק־הדבק.
- יש גרורות מרוחקות? **מדברים עם המתמחה.**
- ממצאי הבירור לפי סדר כרונולוגי.
- מי הכירורג שהפנה ומה האינדיקציה.
- מבקשים סיכום מרופא המשפחה. חוסך זמן בתרופות ובמחלות הרקע.

3 מחלות רקע: מפורט ויסודי

- **מחלת לב איסכמית:** צנתורים, אילו עורקים, מתי ואילו תרופות. אישור קרדיולוג לסיכון הניתוחי ולהפסקת נוגדי קרישה.
- **פרפור פרוזדורים:** הטיפול הקבוע. **אירוע מוחי:** מתי ומה.
- **מחלת ריאות:** סיכום רופא ריאות והתייחסות לסיכון.
- בכל מחלה: יש ייעוץ? מה הוא אומר? חסר ייעוץ? מציינים.
- עוברים על כל התיק ומכניסים את כל הייעוצים.

4 בדיקות טרום ניתוח

טבלת הבדיקות הנחוצות בסביסטון ונהלי המחלקה. הכול מ-3 החודשים האחרונים.

אק״ג	מפרטים. אין, או באיכות לא טובה? עושים שוב.
צילום חזה	אין פענוח? מסתכלים וכותבים. **יש CT חזה? לא צריך צילום.** מציינים ברובריקה.
דם	המוגלובין, טסיות, לויקוציטים, קריאטינין, Na, K, INR. לפי הצורך: סמנים, אלבומין, מדדי דלקת. תאריך ברובריקה.
לא עדכני?	מכתב לרופא המשפחה עם הבדיקות. המטופל מגיע איתן ליום הניתוח.

5 ניתוחים בעבר

- מתי, איזה ניתוח ובאיזה חתך (למשל אפנדקטומי לפרוסקופי או מקברני).
- לא ברשימה? כותבים "לטיפול הרשמת" ואת שם הניתוח בהערות.

6 תרופות קבועות

- **דיוק! מוודאים מול המטופל ומול הרשומות.**
- מינון, תדירות ודרך מתן.
- נוגדי קרישה (אספירין, קומדין, פלביקס, קלקסן ודומיהם): מתי הופסקו ולמה ניתנים.
- מסבירים למטופל מה ממשיכים ומה מפסיקים.

והכי חשוב: מפעילים שיקול דעת ושואלים את המתמחה בכל שאלה.

7 מה מוסיפים לפי תחום

בקעים

- לפי מכתב ההפניה: איזה בקע, איזה תיקון ומה האינדיקציה.
- בדיקה: שני הצדדים והטבור. צלקות קודמות. בגברים גם אשכים.
- שואלים על מתן שתן ונוקטוריה.
- בקע בצלקת: אילו ניתוחים ומתי.

בריאטריה

- מדד מסת גוף (BMI), מחלות רקע ואינדיקציה. עוברים על כל המפגשים במרפאה הבריאטרית.
- שיקוף בליעה, גסטרוסקופיה ו-TSH.
- בדיקות דם: ויטמינים, פריטין ועוד.
- ניתוח קודם כמו טבעת: לציין את הסוג (LAGB, SRVG).

שד

- מרפאת השד או מכתב ההפניה: אפיון הגידול ואינדיקציה.
- **צד ימין או שמאל: חשוב!**
- כרונולוגיה: פתולוגיה, סמנים, סימון מתוכנן (איזוטופים או תיל).
- טיפול נאו־אדג׳ובנטי, בדיקה גנטית ושיתוף פלסטיקאים.

קולון

- הערות המנתח.
- בירור סיסטמי: CT, צילום חזה, PET CT לפי הצורך.
- קולונוסקופיה ו-TRUS אם יש. פתולוגיה (כולל MMR), סמנים ו-MRI.
- טיפול נאו־אדג׳ובנטי והשיפור אחריו.

הפטוביליארי

- איזה ניתוח, התייצגות וסיבת הבירור.
- הבירור המקומי והסיסטמי לפי תאריכים. EUS ו-MRI: יחס לכלי דם.
- פתולוגיה ומרקרים. ניקוז דרכי מרה או ERCP.
- מעבדה: גם אנזימי כבד ובילירובין.

קיבה

- תוצאות גסטרוסקופיה ופתולוגיה.
- טיפול נאו־אדג׳ובנטי.
- תוצאות הבירור הסיסטמי (CT).

✓ לפני שמדפיסים

- ☐ תלונה עיקרית: ניתוח + אינדיקציה
- ☐ מי הכירורג שהפנה
- ☐ הבירור לפי תאריכים
- ☐ כל מחלות הרקע עם הייעוצים
- ☐ אק״ג, צילום חזה (או CT) ודם מ-3 חודשים
- ☐ כל ניתוח ברובריקה שלו, עם חתך
- ☐ תרופות: מינון, תדירות ודרך
- ☐ נוגדי קרישה: מתי הופסקו
- ☐ הוסבר למטופל מה ממשיכים
- ☐ נכתב ע״י: שם הסטאז׳ר/ית
- ☐ אין שום דבר שנשאר לאשפוז
- ☐ הודפס ונחתם

בעמודים הבאים

שלוש קבלות לדוגמה, כתובות לפי ההנחיות. לצד כל אחת: מה בדקנו ולמה.

1. **בקע מפשעתי** — תיקון לפרוסקופי עם רשת
2. **בריאטריה** — OAGB אחרי טבעת
3. **קולון** — כריתת סיגמואיד

קבלות לדוגמה · 1 מתוך 3

בקע מפשעתי

מטופל בן 58, ניתוח אלקטיבי. כך נראית קבלה מלאה בטרום.

המרכז הרפואי קפלן
מרפאת טרום ניתוח · המערך הכירורגי

קבלה רפואית

שם המטופל: **[מטופל לדוגמה]**	ת.ז.: **000000000**	גיל: **58**	תאריך: ___/___/____

לדוגמה בלבד

1 **פרטים**	בן 58, עצמאי, עובד כנהג.
רקע רפואי	יתר לחץ דם. סוכרת. הגדלה שפירה של הערמונית.
2 **נוגדי קרישה**	Aspirin למניעה ראשונית. לפי המנתח: הפסקה 7 ימים לפני הניתוח.
רקע ניתוחי	• כריתת תוספתן בגישה פתוחה, בילדות.
תלונה עיקרית	הופנה לתיקון בקע מפשעתי ימני בגישה לפרוסקופית עם רשת, בשל בקע סימפטומטי.
3 **מחלה נוכחית**	מזה כשנה בליטה במפשעה ימין, מחמירה במאמץ ובעמידה, עם כאב מקומי. ללא אירועי כליאה. נבדק במרפאת הבקעים ב-10/2026, הומלץ על תיקון לפרוסקופי. US מפשעות 09/2026: בקע מפשעתי ימני משמאל ללא בקע. מתאר נוקטוריה פעמיים בלילה וזרם חלש. ללא אצירת שתן בעבר.
1 **בדיקה גופנית**	מפשעה ימין: בליטה שנכנסת לבד, מתבלטת בשיעול. מפשעה שמאל וטבור: ללא בקע. צלקת מקברני. אשכים תקינים.
בדיקות	• אק״ג 10/2026: קצב סינוס, ללא שינויים איסכמיים. • צילום חזה 10/2026: תקין. • מעבדה 10/2026: ספירה וכימיה תקינות. INR 1.0. גלוקוז 132.
תרופות קבועות	• Amlodipine 5 מ״ג, פעם ביום. • Metformin 850 מ״ג, פעמיים ביום. • Tamsulosin 0.4 מ״ג, פעם ביום. • Aspirin 100 מ״ג, פעם ביום.
רגישויות	ללא רגישות ידועה לתרופות.
4 **הוסבר למטופל**	Metformin: לא בבוקר הניתוח. Aspirin: לפי הנחיית המנתח. שאר התרופות כרגיל.

נכתב ע״י: סטאז׳ר/ית [שם] על קוד של ד״ר [שם] — הודפס ונחתם ✓

שימו לב

1. צד הבקע כתוב במפורש. נבדקו שני הצדדים, הטבור והאשכים.
2. נוגדי טסיות: התרופה, האינדיקציה ומתי מפסיקים.
3. מתן שתן: יש סיכון לאצירה אחרי הניתוח, לכן שואלים.
4. מה ממשיכים ומה מפסיקים: נאמר למטופל ונכתב.

קבלות לדוגמה · 2 מתוך 3

ניתוח בריאטרי

מטופלת בת 41 אחרי טבעת קיבה. כאן כל ניתוח קודם וכל מפגש במרפאה נחשבים.

המרכז הרפואי קפלן
מרפאת טרום ניתוח · המערך הכירורגי

קבלה רפואית

שם המטופל: **[מטופל לדוגמה]**	ת.ז.: **000000000**	גיל: **41**	תאריך: ___/___/____

לדוגמה בלבד

1 פרטים — בת 41, עצמאית. משקל 118 ק״ג, גובה 166 ס״מ, BMI 42.8.

רקע רפואי — יתר לחץ דם. דום נשימה בשינה, ישנה עם CPAP. כבד שומני. טרום סוכרת.

נוגדי קרישה — ללא.

2 רקע ניתוחי
- 2012: ניתוח קיסרי.
- 2015: טבעת קיבה מתכוננת (LAGB) בגישה לפרוסקופית.
- 2019: הוצאת הטבעת בגישה לפרוסקופית, עקב צרבת קשה.

אנדוסקופיות — גסטרוסקופיה 08/2026: גסטריטיס קלה, HP שלילי. ללא בקע סרעפתי.

תלונה עיקרית — הופנתה למעקף קיבה בהשקה אחת (OAGB) בגישה לפרוסקופית, בשל השמנה חולנית עם תחלואה נלווית.

3 מחלה נוכחית — השמנה מגיל צעיר. אחרי הטבעת ירדה 20 ק״ג ועלתה חזרה. ניסיונות דיאטה חוזרים ללא הצלחה. במרפאה הבריאטרית: כירורג 08/2026, דיאטנית (שני מפגשים) ופסיכולוגית 08/2026: מתאימה לניתוח. אושרה בוועדה הבריאטרית 09/2026. שיקוף בליעה 07/2026: מעבר תקין.

בדיקות
- אק״ג 10/2026: קצב סינוס, תקין.
- צילום חזה 10/2026: תקין.
- מעבדה 10/2026: ספירה וכימיה תקינות. ALT 48. TSH 2.1.
- ויטמינים 09/2026: ויטמין D 18, נמוך, החלה תוסף. פריטין 22. B12 וחומצה פולית תקינים.

תרופות קבועות
- Ramipril 5 מ״ג, פעם ביום.
- Omeprazole 20 מ״ג, פעם ביום.
- ויטמין D 2000 יחידות, פעם ביום.

רגישויות — Penicillin: פריחה.

4 הוסבר למטופלת — Ramipril: לא בבוקר הניתוח. להביא את מכשיר ה-CPAP לאשפוז.

נכתב ע״י: סטאז׳ר/ית [שם] על קוד של ד״ר [שם] — הודפס ונחתם ✓

שימו לב

1. משקל, גובה ו-BMI יחד עם התחלואה הנלווית: זו האינדיקציה.
2. ניתוח בריאטרי קודם: הסוג, מתי ולמה הוצא.
3. כל המפגשים במרפאה הבריאטרית והוועדה, עם תאריכים.
4. CPAP: נכתב בקבלה כדי שיגיע איתה לאשפוז.

קבלות לדוגמה · 3 מתוך 3

גידול בסיגמה

מטופל בן 67 עם רקע לבבי ונוגדי קרישה. כאן הבירור והייעוצים הם העיקר.

המרכז הרפואי קפלן
מרפאת טרום ניתוח · המערך הכירורגי

קבלה רפואית

שם המטופל: **[מטופל לדוגמה]**	ת.ז.: **000000000**	גיל: **67**	תאריך: ___/___/____

לדוגמה בלבד

פרטים	בן 67, עצמאי וצלול.
רקע רפואי	מחלת לב איסכמית, צנתור עם תומכן ל-LAD ב-2021. פרפור פרוזדורים התקפי. סוכרת.
1 נוגדי קרישה	• Eliquis בשל פרפור פרוזדורים. מנה אחרונה 48 שעות לפני הניתוח. • Aspirin. ממשיך לפי הקרדיולוג.
רקע ניתוחי	• 2010: כריתת כיס מרה בגישה לפרוסקופית.
אנדוסקופיות	קולונוסקופיה 08/2026: גידול חוסם חלקית בסיגמה, 25 ס״מ מפי הטבעת. סומן בטטו. פתולוגיה: אדנוקרצינומה, MMR תקין.
תלונה עיקרית	הופנה לכריתת סיגמה בגישה לפרוסקופית בשל אדנוקרצינומה של הסיגמה.
2 מחלה נוכחית	מ-07/2026 דמם רקטלי לסירוגין וחולשה. במעבדה אנמיה, המוגלובין 11.2. הופנה לקולונוסקופיה. CT חזה, בטן ואגן 08/2026: עיבוי דופן בסיגמה, ללא קשריות מוגדלות, ללא גרורות. CEA 3.8. נבדק במרפאה הקולורקטלית 09/2026, הוסבר על אפשרות לסטומה זמנית.
4 ייעוצים	קרדיולוג 09/2026: אקו עם EF 55%. סיכון ניתוחי בינוני, ניתן לנתח. להמשיך Aspirin. Eliquis: הפסקה 48 שעות לפני, ללא גישור.
3 בדיקות	• אק״ג 10/2026: קצב סינוס, ללא שינוי מאק״ג קודם. • צילום חזה: לא בוצע, יש CT חזה מ-08/2026. • מעבדה 10/2026: המוגלובין 11.8, קריאטינין 1.1, INR 1.1, אלבומין 3.9. שאר הספירה והכימיה תקינות.
תרופות קבועות	• Aspirin 100 מ״ג, פעם ביום. • Eliquis 5 מ״ג, פעמיים ביום. • Bisoprolol 2.5 מ״ג, פעם ביום. • Atorvastatin 40 מ״ג, בערב. • Metformin 1000 מ״ג, פעמיים ביום. • Jardiance 10 מ״ג, פעם ביום.
הוסבר למטופל	Eliquis: מנה אחרונה 48 שעות לפני. Jardiance: להפסיק 3 ימים לפני. Metformin: לא בבוקר הניתוח. השאר כרגיל.

נכתב ע״י: סטאז׳ר/ית [שם] על קוד של ד״ר [שם] — הודפס ונחתם ✓

שימו לב

1. נוגדי קרישה: התרופה, האינדיקציה ומתי המנה האחרונה.
2. הבירור לפי סדר כרונולוגי, כל ממצא עם תאריך.
3. יש CT חזה, ולכן אין צילום חזה. זה כתוב.
4. ייעוץ קרדיולוג: מה הסיכון ומה עושים עם נוגדי הקרישה.